

Bases Radiographie Thoracique

Facteurs de qualité :

- Debout + Bras tendus des côtés
- Inspiration Profonde
- Incidence Postéro - Antérieure

↳ Index cardio-thoracique $\frac{C}{T} > 0,55$

↳ Cardiomégalie

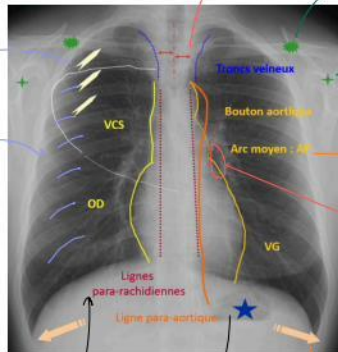


Lecture : Supr "Ph" "P"

Arc Costal

Minimum 6

Espaces A Costale visible



Equidistance clavicle par rapport ligne A spinale

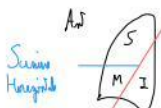
Clavicule Symétriques

Scapula déviés

Cul de Sac costal - Claviculaire

(Latéral et Postérieur)

Poumon Droit



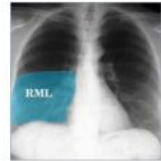
Post



Lobe supérieur droit



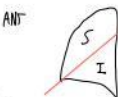
Lobe moyen



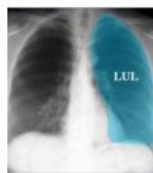
Lobe inférieur droit



Poumon Gauche



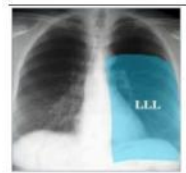
Post



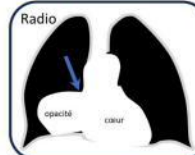
Lobe supérieur gauche



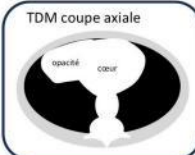
Lobe inférieur gauche



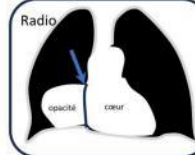
Signe de la silhouette



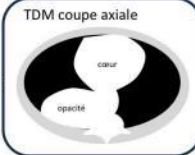
Opacité du LM
L'opacité est dans le même plan AP que le cœur: pas de limite visible (flèche) entre les 2



Silhouette - : Lobe Moyen



Opacité du LID
L'opacité et le cœur sont dans 2 plans ≠: limite visible (flèche) entre les 2

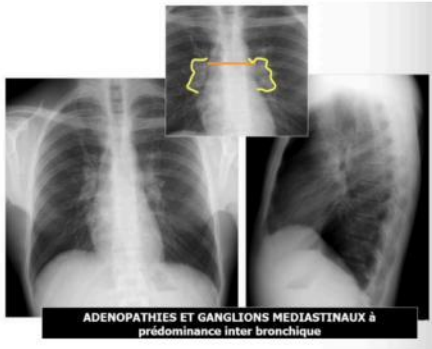
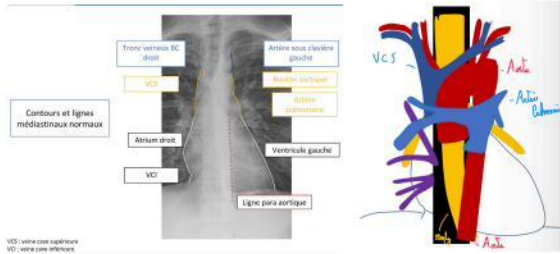


Silhouette + : Lobe Inférieur

Radi - Frontal



Anomalies Médiastrales



Élargissement des hile pulmonaires

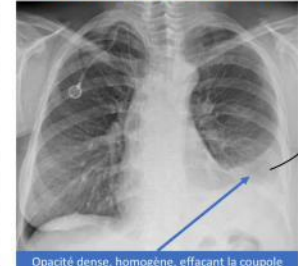
Épanchement Pleural liquidien

0: liquide dans la plèvre (entre feuillets viscéral et parietal)

Radiographies de thorax de face



Épanchement pleural droit de faible abondance



Épanchement pleural gauche de moyenne abondance

Liquide = opacité

+ déviation médiastinale cardio-basale (trachée)

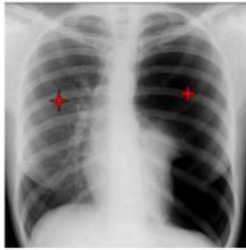
diag différentiel: Pas de bronchogramme aérique (→ infection)

Hémithorax + Volumineux mais Fin

Pneumothorax: Volumineux + ++ J long

Emphysème Pleural Gazeux (pneumothorax)

Gaz dans la plèvre = Hyponchisme
 décalage "ligne bordante du psvmon"



Complète compressif

Compression: déviation cardio-latérale

+ Psvmon atelectasé et rétracté sur le hile
 (Absol sans air)

+ élargissement espaces intercostaux

Jamais
 médian

Signes fonctionnels	Signes physiques
▪ Douleur thoracique - brutale, homolatérale, latérothoracique ou postérieure) - rythmée par la respiration (↗ à la toux) - survenant presque toujours au repos - s'estompe souvent rapidement ▪ Dyspnée d'intensité variable, inconstante ▪ Toux sèche irritative ▪ Aucun symptôme	▪ Hémithorax normal ou distendu et moins mobile ▪ Diminution du murmure vésiculaire ▪ Abolition de vibrations vocales ▪ Tympanisme à la percussion ▪ Orientation étiologique (traumatisme)

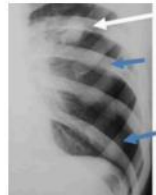
Se voit dans un PNO compressif.

"man" d'Air STOP bruit

Mécanisme récepteur de la plèvre

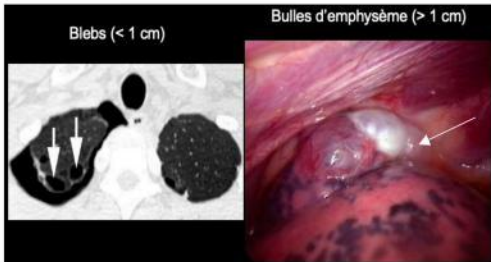
Changement position = Déplacement Air = Irritation = Toux sèche et brève

Traitement = drain thoracique



PNO (= Pneumothorax) → Spontanée - Primaire [Pas de pathologie]
 Secondaire [Pathologie connue]
 Traumatique

Gravité: compressif et tamponnade gazeuse + I resp

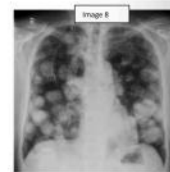


Blebs = bulle d'empysem
 PNO se rompt

Empysemes palpable crâne sans douleur

Hydropneumothorax = liquation + gazeux
 épanchement
 col de sac
 décalage du psvmon
 ne voit pas la ligne de Damazian

Tumeurs parenchymateuses pulmonaires
Opacités en "bâtons de ballons"



Infections (Pneumopathies)

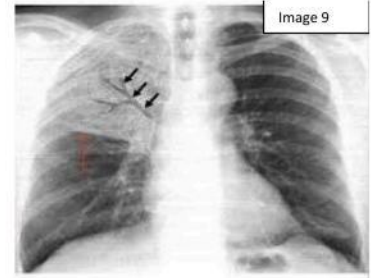
Réaction inflammatoire → Exsudat (liquide, cellules, débris ^{et mucus})

Remplissage Alvéolaire

Toutes les alvéoles du lobe

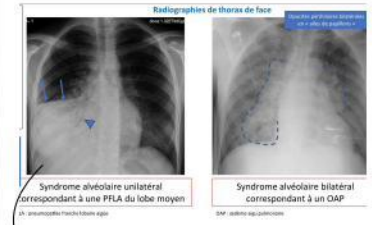
(concrète par les "lignes de Kohn")

pas les gros trajets = Bronchogramme Aérique



début lésion à apex droit
↓ Sur lobe
↓ apex gauche
↓ apex bas

PFLA = Pneumonie franche lobaire aiguë



+ Bronchogramme aérique

Atélectasie (= atelectasie)

↳ Obstruction bronchique

N'y a plus d'air (pression barométrique)

Obstruction Bronchique

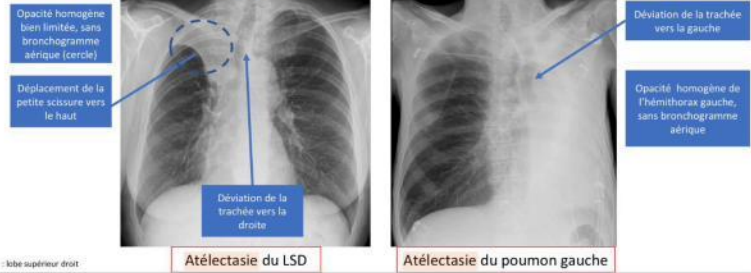
N'y a plus d'air dans les alvéoles → Rétraction Alvéolaire

= Opacité + Atréactif

Bronchogramme Aérique

Dériv° Homolatéral

Radiographies de thorax de face (deux patients distincts)



lobe supérieur droit

Atélectasie du LSD

Atélectasie du poumon gauche

Œdème Aiguë Pulmonaire

OAP de Surcharge (cardiogénique)

- Insuffisance cardiaque gauche ("fatigue")
- Sténose mitrale / Insuffisance Aortique
- HTA
- Surcharge de liquides (IR)

P↑ = transsudat

S° Opacités péri-hilaires BILATÉRALES

OAP Réactionnel (SDRA)

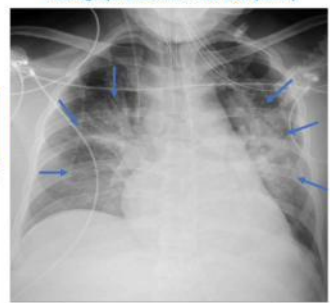
- Infection Sévère
- Intoxication de Toxique
- Trauma

Membrane alvéolo-capillaire Altérée

Radiographie de thorax de face (au lit)

Opacités peu denses, confluentes, à limites floues, de répartition périhilaire bilatérale (« aile de papillon »)

Signes supplémentaires si radio faite en position debout (rarement) : lignes de Kerley (voir encadré), redistribution vasculaire vers les sommets, cardiomégalie (ne s'apprécie pas sur une radio faite en position couchée), épanchement pleural



Œdème aigu du poumon